Cerebelo, conciencia, lesiones cerebrales e infecciones del SNC

FISIOPATOLOGIA · Clase 38 · ataxia y equilibrio, Glasgow, meningitis y encefalitis, mielina, Alzheimer y migraña

1 · EL CEREBELO Y LA DESCOORDINACIÓN

Cerebelo F11
compara la orden con el movimiento real y corrige; coordinan sistema motor, vestibular, sensitivo y cerebeloso, no el vegetativo

Causa de ataxia F16
esclerosis múltiple (la más frecuente entre las opciones del banco); también alcohol, infartos y tumores

daña el cerebelo y causa la

también integra el — *es una causa de*

si falla se produce la

Lesión cerebelosa F10
se rompe la comparación entre orden y ejecución: el movimiento se vuelve torpe y se descompone

su atrofia se ve en imagen pero no es

en el tronco causa la

en la marcha causa

al acercarse a la meta causa

en lo alternante causa

en el habla causa

en los ojos puede dar

Atrofia cerebelosa F12
hallazgo de imagen o causa; no es un signo clínico

Disfunción vestibulocerebelosa F13
pierde el equilibrio del tronco y no mantiene una postura constante

Ataxia F15
marcha de base ancha e inestable; en la distaxia grave cada parte del movimiento sale por separado

Temblor intencional F17
oscila al moverse y empeora al acercarse a la meta

Disdiadococinesia F19
no logra movimientos rápidos alternantes (pronación-supinación)

Disartria cerebelosa F18
habla lenta, mal articulada y de volumen variable

Nistagmo F14 · F21
reajuste conjugado de los ojos con fase lenta y rápida; horizontal, vertical, rotatorio o mixto

al perder el tronco termina en

termina en

termina en

suma al cuadro de

suma al cuadro de

suma al cuadro de

es un movimiento anormal, como los

Movimientos anormales F20
corea, distonía, temblor y bradicinesia; la hiperreflexia es de la vía motora y no lo es

Marcha insegura y gesto impreciso: el paciente no alcanza la meta y puede caer

2 · EQUILIBRIO, NISTAGMO Y MAREO

Equilibrio
se integra con la vista, el sistema vestibular y la propiocepción; el cerebelo las compara

si falla la propiocepción hay

si se daña el oído interno hay

si vista y oído no coinciden hay

Déficit de propiocepción F24
el desequilibrio nace de un déficit sensorial

Neuritis vestibular F25
el único nervio dañado es el VIII par (no el II ni el VI)

Mareo por movimiento
la señal visual no coincide con la vestibular

causa

produce

Desequilibrio: el cuerpo no sabe dónde está ni hacia dónde se mueve

el cuerpo responde con

Respuesta del cuerpo F22
hipotensión, taquicardia y sudoración excesiva

se resuelve cuando las señales vuelven a

El mareo cede cuando lo que se ve coincide con lo que siente el sistema vestibular F23

3 · CONCIENCIA, GLASGOW Y CORTEZA

Conciencia F3
se apaga por lesión del tallo cerebral o por compromiso bihemisférico difuso; la corteza orbitofrontal no la apaga

si la lesión es parcial hay

se mide con la

Escala de Glasgow F1 · F9 · F33
suma apertura ocular (1-4), respuesta verbal (1-5) y motora (1-6): de 3 a 15

tiene valores clave

un puntaje ≤ 8 es

≤ 8 = coma grave F33
9-12 y 13-15 son cortes convencionales

exige

Glasgow ≤ 8: coma grave que exige proteger la vía aérea y vigilancia continua

Valores que caen F1 · F9
extensión (descerebración) = 2; ocular a la orden verbal = 3; sonidos incomprensibles = 2; retirada = 4

Lesión de un área cortical
daña una función concreta sin apagar la conciencia

en el giro angular da

en la vía visual da

Síndrome de Gerstmann F4
giro angular dominante: agnosia digital, confusión derecha-izquierda, acalculia y agrafia; la disfagia no pertenece

Vías ópticas
quiasma: hemianopsia bitemporal; después del quiasma: hemianopsia homónima contralateral

deja un

deja un

Déficit focal: la persona está despierta pero pierde una función

4 · MENINGITIS Y ENCEFALITIS

Infecciones del SNC
el sitio inflamado decide el cuadro: meninges o parénquima

Neumococo F29
agente más frecuente de meningitis bacteriana en adultos

si afecta el parénquima

si afecta las meninges

es el agente más frecuente de

Meningitis F26
inflama aracnoides y piamadre (leptomeninges), todas las capas menos la duramadre; pus entre las meninges

Encefalitis F27
inflama el parénquima: hemorragias necrosantes locales, desorientación y convulsiones focales; lo degenerativo no es propio

se confirma con la

produce el

se separa de la meningitis por

Cuadro clínico F28
fiebre, cefalea, rigidez de nuca, desorientación, letargo y alteración neurológica

Punción lumbar F30
LCR purulento, proteínas altas, glucosa baja y polimorfonucleares

aporta el dato para

se separa de la encefalitis por

Para diferenciar
rigidez de nuca y LCR purulento: meningitis; alteración cortical y convulsiones: encefalitis

define el

Se define meningitis bacteriana o encefalitis y se trata según el agente

5 · MIELINA: QUIÉN LA FORMA Y CUÁNDO SE PIERDE

Mielina
aislante del axón que acelera el impulso nervioso

en el SNC la forma el

en el SNP la forma la

SNC: oligodendrocito F6 · F32
mieliniza varios axones a la vez

SNP: célula de Schwann F5 · F32
rodea un segmento de un solo axón

si se pierde, causa

su daño explica el

Esclerosis múltiple
el ataque inmune destruye mielina y oligodendrocitos del SNC

Guillain-Barré
ejemplo de desmielinización periférica: daña a la célula de Schwann

enlentece el impulso y deja

Impulso enlentecido: déficits neurológicos como la ataxia, en brotes

6 · NEURONAS QUE SE PIERDEN Y MIGRAÑA

Pérdida neuronal
mueren las neuronas mismas: ELA y Alzheimer; la migraña no mata neuronas

Factores F7
presenilinas, ApoE4, herencia y TEC repetidos

aparte, sin matar neuronas, hay

en la médula motora ocurre la

en la corteza ocurre el

favorecen el

ELA F2
mueren las motoneuronas del asta anterior (y las corticales); el músculo, sin su nervio, se atrofia

Alzheimer F7 · F31
placas de β-amiloide y ovillos neurofibrilares de tau hiperfosforilada

Migraña F34
activa el sistema trigeminovascular y libera CGRP

avanza hasta la

termina en

en la crisis se trata con

Debilidad progresiva; la muerte suele llegar por falla respiratoria

Pérdida neuronal progresiva: demencia con atrofia cortical

Crisis: AINE (ibuprofeno, diclofenaco) y dihidroergotamina (específica) F8

concepto · causa · mecanismo · ejemplo · síndrome · signo · desenlace · diagnóstico · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Literatura (sin clase del docente en el vault) · preguntas del banco, lámina 38